

Instructivo de Proceso y Registro GES

Versión 1.0 – Febrero 2023

69. Hepatitis Crónica por virus Hepatitis C

Departamento GES, Redes de Alta Complejidad y Líneas Programáticas
Departamento Planificación Presupuestaria y Gestión de la Información

Tabla de Contenido

Introducción	3
1. Aspectos del Problema de Salud	4
2. Extracto del Decreto Vigente n° 72/2022	
2.1 Definición	4
2.2 Garantías de acceso	4
2.3 Garantías de oportunidad	4
2.4 Garantía protección financiera	4
3. Proceso de atención	
3.1 Ciclo de atención	5
3.2 Flujograma	6
4. Registro SIGGES	8

Introducción

El presente documento tiene por propósito entregar una herramienta práctica que reúna elementos del proceso de atención, gestión y registro de cada uno de los problemas de salud garantizados bajo la normativa vigente.

El documento consta de los siguientes puntos:

1. **Aspectos del problema de Salud:** describe la historia del problema de salud desde su entrada en régimen.
2. **Extracto del Decreto vigente:** incluye la definición del problema de salud, las garantías de acceso, de oportunidad y de protección financiera.
3. **Proceso de Atención:** corresponde al ciclo de atención que sigue cada paciente GES, según las definiciones y normativas del Ministerio de Salud. Tiene como finalidad guiar la aplicación del decreto y su registro asociado.
4. **Hitos de Registro:** detalla los hitos de atención a registrar en el SIGGES de acuerdo a las definiciones del decreto y del proceso de atención, la cual está estructurada según las etapas de atención, las garantías de oportunidad y las intervenciones sanitarias correspondientes a este problema de salud, entregando de esta forma, los principales aspectos requeridos para el registro y posterior análisis y monitoreo de la información relacionada a este problema de salud.

1. Aspectos del Problema de Salud

Este problema de salud entró en vigencia con el Decreto N° 1 del año 2010, garantizando las etapas de diagnóstico y tratamiento. El Decreto Modificatorio del año 2018, incluyó nuevas terapias farmacológicas. El Decreto N° 22 del año 2019 cambia el nombre del problema de salud y se incorporan nuevos tratamientos farmacológicos y exámenes (elastografía). El Decreto N° 72 del año 2022, modifica y actualiza los tratamientos farmacológicos.

2. Extracto del Decreto vigente: Decreto N° 72 del 2022

2.1 Definición

Enfermedad hepática causada por el virus hepatitis C, es transmitida principalmente por la vía parenteral, es decir por transfusiones de sangre no analizadas para detectar este virus o derivados de productos sanguíneos, uso de jeringas no desinfectadas o tatuajes y en menor medida por relaciones sexuales o de madre a hijo. La mayoría de las infecciones se presentan en estado crónico, pudiendo desarrollar en el tiempo cirrosis y cáncer hepático.

2.2 Garantía de Acceso

Todo beneficiario:

- i. Con factores de riesgo tendrá acceso a la sospecha a través de examen de virus de hepatitis C.
- ii. Con sospecha, tendrá acceso a confirmación diagnóstica.
- iii. Con confirmación diagnóstica, tendrá acceso a evaluación pretratamiento.
- iv. Con evaluación pretratamiento, tendrá acceso a tratamiento antiviral de acción directa.
- v. Con tratamiento, tendrá acceso a continuarlo.
- vi. Con tratamiento completo tendrá acceso a control postratamiento por un año posterior al término de la terapia.
- vii. Con tratamiento completo, sin curación, tendrá derecho a terapia de rescate.

2.3 Garantía de oportunidad

Diagnóstico

- i. La confirmación diagnóstica se realizará dentro de 45 días desde la sospecha.

Tratamiento

- i. La evaluación pretratamiento se realizará dentro de 30 días desde confirmación diagnóstica.
- ii. El tratamiento farmacológico se iniciará dentro de 30 días desde la indicación médica (general y de rescate).

NTMA

2.4 Garantía de protección financiera

Nº	Problema de salud	Tipo de Intervención 3.1n Sanitaria	Prestación o grupo de prestaciones	Periodicidad	Arancel (\$)	Copago %	Copago \$
69	Hepatitis crónica por virus hepatitis C	Diagnóstico	Sospecha de VHC en nivel primario	Cada vez	3.900	20%	780
			Confirmación de VHC	Cada vez	37.150	20%	7.430
		Tratamiento	Evaluación paciente VHC pretratamiento	Cada vez	283.770	20%	56.750
			Evaluación hepática por elastografía	Cada vez	23.060	20%	4.610
			Tratamiento farmacológico con antivirales pangenotipo	Por tratamiento completo	4.368.880	20%	873.780
			Tratamiento farmacológico de rescate con antiviral pangenotipo	Por tratamiento completo	4.476.350	20%	895.270
			Control a pacientes con tratamiento farmacológico del VHC	Por tratamiento completo	60.880	20%	12.180
			Control a pacientes VHC sin tratamiento farmacológico o en control postratamiento	Anual	322.180	20%	64.440

3. Proceso de Atención

3.1 Ciclo de atención

Frente a una persona que presenta factores de riesgo asociados a hepatitis C (detallados en la NTMA), el médico tratante de atención primaria o del nivel secundario indica el examen de anticuerpos para Virus de Hepatitis C, abriendo el caso Ges en hoja diaria u hoja de especialidad según corresponda, generando la garantía de confirmación diagnóstica, la cual deberá cumplirse dentro de 45 días desde la sospecha.

Si el resultado de este examen resulta reactivo a nivel local, se debe enviar una muestra al Instituto de Salud Pública. Si éste resulta positivo (ISP), se confirma el caso en Hoja diaria o emitiendo un Informe de Proceso Diagnóstico (IPD), según el nivel de atención. Luego de la confirmación diagnóstica, se genera la garantía de evaluación pretratamiento, la cual deberá ser cumplida en un plazo de 30 días.

Si el resultado según ISP es negativo se cierra el caso, en el nivel que corresponda.

Si la confirmación se hace en APS se deberá derivar con una Solicitud de Interconsulta (SIC) a médico especialista (gastroenterólogo, internista, hepatólogo o infectólogo) en el nivel secundario, traspasando la garantía de evaluación pretratamiento a este nivel de atención.

Luego de completar la evaluación pretratamiento, médico especialista indica la terapia farmacológica, que tiene un plazo máximo de 30 días para su inicio, desde la indicación médica, debiendo emitir una Orden de Atención (OA) para la generación de la garantía.

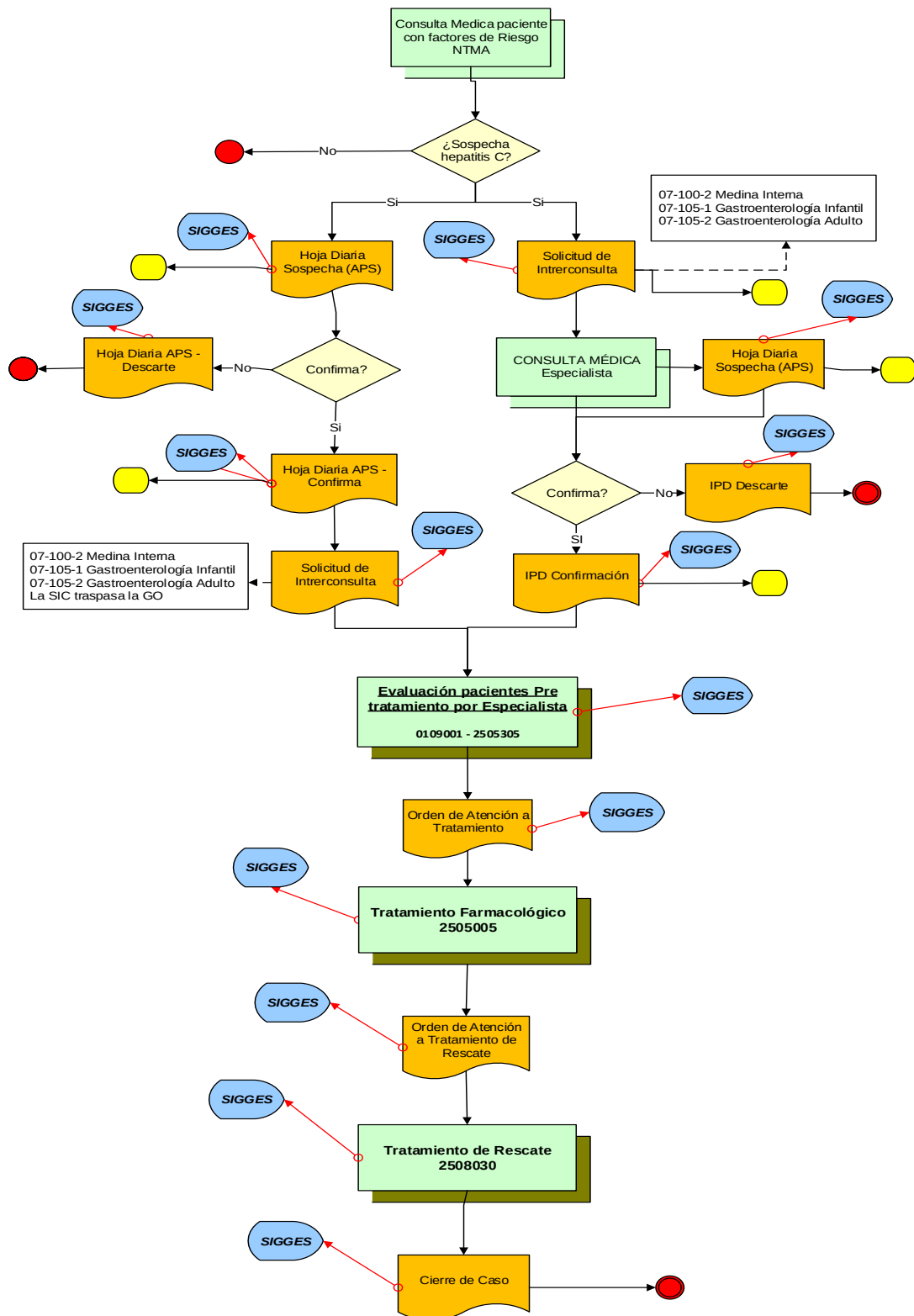
Durante el tratamiento, el médico tratante puede indicar el examen de elastografía, emitiendo una OA o una SIC y derivando al establecimiento que corresponda por red. Esta prestación no tiene garantía de oportunidad.

Una vez finalizado el tratamiento farmacológico, el médico indica control a las 12 semanas posteriores al inicio del tratamiento para evaluar la eliminación viral. Este control no tiene plazo garantizado.

Si el médico verifica que la persona recibió la totalidad del tratamiento y no hubo curación, le indica terapia de rescate, que corresponde a una nueva indicación de tratamiento farmacológico, debiendo, a través de la emisión de una nueva OA, gatillar la garantía de oportunidad de 30 días desde la indicación médica.

El caso GES se podrá cerrar cuando haya transcurrido un año posterior al término de la terapia farmacológica, posterior a la negativización del virus en el usuario, dado que el decreto garantiza el acceso a control postratamiento por un año.

3.2 Flujoograma



4. Registro SIGGES

4.1 Tabla Resumen

Etapas	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
Sospecha	Médico APS sospecha Hepatitis C Crónica en usuario con antecedente de Hepatitis C confirmada	SIC: derivada a Confirmación Diagnóstica, Control Especialidad, Realizar Tratamiento, Otros Especialidad 07-100-2: Medicina Interna 07-105-1: Gastroenterología Infantil 07-105-2: Gastroenterología Adulto	Diagnóstico		X		Confirmación Diagnóstica dentro de 45 días desde la sospecha	Establecimiento de destino de la SIC, hasta que se ingrese nueva SIC el responsable es el establecimiento destino de la SIC	X	
	Médico tratante de usuario con Hepatitis C sospecha presencia de cronicidad Médico especialista de otro problema de salud sospecha Hepatitis C crónica y deriva al usuario al especialista	HD: sospecha	Diagnóstico		X		Confirmación Diagnóstica dentro de 45 días desde la sospecha	Establecimiento que emite la HD, hasta que se ingrese nueva SIC el responsable es el establecimiento destino de la SIC	X	

Instructivo de Proceso y Registro GES
69. Hepatitis Crónica por Virus Hepatitis C

Etapa	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
Proceso Diagnóstico Cronicidad	Médico Especialista solicita la realización de exámenes	PO: Examen	Diagnóstico/ Sospecha del virus Hepatitis C en nivel primario	2504094: Sospecha del virus Hepatitis C en nivel primario		X	---			---
		PO: Examen	Diagnóstico/ Sospecha del virus Hepatitis C en contacto epidemiológico	2504142: Sospecha del virus Hepatitis C en contacto epidemiológico		X	---			---
		PO: Examen	Diagnóstico/ Confirmación de VHC	0305182: Reacción de polimerasa en cadena (P.C.R.), virus influenza, virus herpes, citomegalovirus, hepatitis C, mycobacteria TBC, c/u (incluye toma muestra hisopado nasofaríngeo)		X	---			---
Confirmación	Médico confirma o descarta la cronicidad con los resultados de los exámenes	IPD: confirma/ descarta el caso	Diagnóstico		X		Confirmación Diagnóstica dentro de 45 días desde la sospecha			X
		HD: confirma/ descarta el caso	Diagnóstico		X		Confirmación Diagnóstica dentro de 45 días desde la sospecha			X

Instructivo de Proceso y Registro GES
69. Hepatitis Crónica por Virus Hepatitis C

Etapa	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
Tratamiento	Médico confirma la cronicidad con los resultados de los exámenes	IPD: Confirmación	Tratamiento		X		Evaluación Pretratamiento dentro de 30 días desde confirmación diagnóstica	Establecimiento que emite el IPD, hasta que se ingrese nueva SIC/OA el responsable es el establecimiento destino de la SIC/OA	X	
		HD: Confirmación	Tratamiento		X		Evaluación Pretratamiento dentro de 30 días desde confirmación diagnóstica	Establecimiento que emite la HD, hasta que se ingrese nueva SIC/OA el responsable es el establecimiento destino de la SIC/OA	X	
	Médico indica evaluación previa al tratamiento para definir plan terapéutico	PO: consulta	Tratamiento/ Evaluación paciente VHC pre-tratamiento	2505305: Evaluación paciente VHC pre-tratamiento		X	Evaluación Pretratamiento dentro de 30 días desde confirmación diagnóstica			X
		PO: consulta	Tratamiento/ Evaluación paciente VHC pre-tratamiento	0109001: Consulta telemedicina		X	Evaluación Pretratamiento dentro de 30 días desde confirmación diagnóstica			X
		PO: consulta	Tratamiento/ Evaluación hepática por elastografía	2508053: Evaluación hepática por elastografía		X	---			---

Instructivo de Proceso y Registro GES
69. Hepatitis Crónica por Virus Hepatitis C

Etapa	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
Tratamiento	Medico indica plan terapéutico farmacológico	OA:	Tratamiento				Tratamiento Farmacológico dentro de 30 días desde la indicación	Establecimiento destino de la OA, hasta que se ingrese nueva OA el responsable es el establecimiento destino de la OA	X	
		PO:	Tratamiento/ Tratamiento farmacológico con antivirales pangenotipo	2505005: Tratamiento farmacológico con antivirales pangenotipo		X	Tratamiento Farmacológico dentro de 30 días desde la indicación			X
		OA: derivada a Tratamiento	Tratamiento				Tratamiento de Rescate dentro de 30 días desde la indicación	Establecimiento destino de la OA, hasta que se ingrese nueva OA el responsable es el establecimiento destino de la OA	X	
		PO:	Tratamiento/ Tratamiento farmacológico de rescate con antiviral pangenotipo	2508030: Tratamiento farmacológico de rescate con antiviral pangenotipo		X	Tratamiento de Rescate dentro de 30 días desde la indicación			X

Instructivo de Proceso y Registro GES
69. Hepatitis Crónica por Virus Hepatitis C

Etapa	Atención	Hito Registro SIGGES	Intervención Sanitaria	Prestación Trazadora	Cambio de Etapa	Pago	Garantía de Oportunidad			
							Garantía y Plazo	Responsable de GO	Inicio de Garantía	Cierre de Garantía
Tratamiento	Medico realiza control a pacientes con VHC	PO:	Tratamiento/ Control a pacientes con tratamiento farmacológico del VHC	2505886: Control a pacientes con tratamiento farmacológico del VHC		X	---			---
		PO:	Tratamiento/ Control a pacientes sin tratamiento farmacológico o en control post tratamiento	2505887: Control a pacientes sin tratamiento farmacológico o en control post tratamiento		X	---			---
Cierre de Caso	Medico indica cierre de caso cuando haya transcurrido un año posterior al término de la terapia farmacológica, posterior a la negativización del virus en el usuario	Causal: Término de tratamiento (o causas atribuibles al paciente)			X					

NOTA: Del **Responsable de la garantía de oportunidad:** en el caso que en la Orden de Atención (OA) el establecimiento de destino es del extrasistema, entonces, el responsable de la garantía es el establecimiento Origen de la OA.